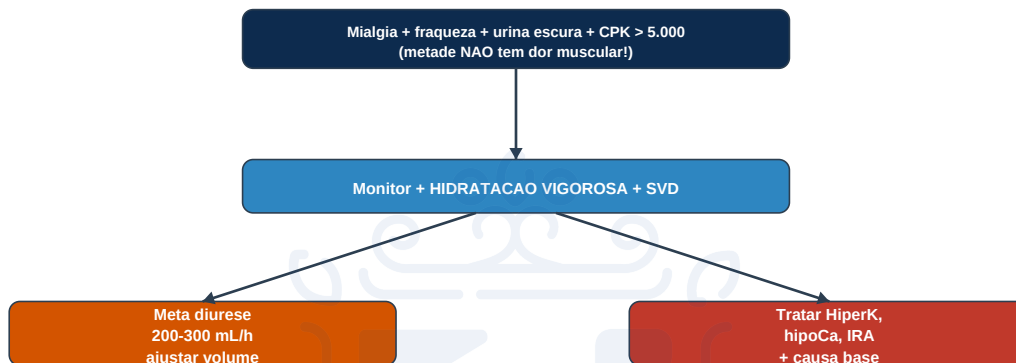


RABDOMIÓLISE — HIDRATAR E PROTEGER O RIM

FLUXOGRAMA — ABORDAGEM

RABDOMIÓLISE — VOLUME É O TRATAMENTO



DEFINIÇÃO

O QUE É

- Quebra rápida das fibras musculares com liberação de mioglobina, CPK, ácido úrico e íons celulares na corrente sanguínea
- A mioglobina é nefrotóxica -> risco de injúria renal aguda
- Tríade clássica: dor muscular + fraqueza + urina escurecida (castanho-avermelhada)
- CUIDADO: mais da METADE dos pacientes NÃO apresenta dor muscular

CAUSAS — BUSCAR ATIVAMENTE

Grupo	Exemplos
Traumática	Trauma, esmagamento, choque elétrico, queimaduras, imobilização prolongada
Esforço/térmica	Atividade física extenuante, desregulação térmica (hipertermia)
Medicamentos	Estatinas, colchicina, ISRS, zidovudina, lítio, anti-histamínicos
Substâncias	Álcool, cocaína, anfetaminas, LSD
Outras	Acidente ofídico/picada, dermatopolimiosite/polimiosite, infecções

RED FLAGS — COMPLICAÇÕES

VIGIAR E TRATAR

- Insuficiência renal aguda (mioglobinúria) — principal complicação
- HIPERCALEMIA (potencialmente fatal) — monitorização cardíaca contínua
- Hipocalcemia, hiperfosfatemia, hiperuricemia
- Hipovolemia (sequestro de líquido no músculo lesado)
- Síndrome compartimental (sobretudo no trauma) — avaliar perfusão/pressão do compartimento

EXAMES

SOLICITAR

- CPK — marcador de maior sensibilidade (rabdomiólise se > 5.000 , ou 5x o limite superior)
- Função renal (ureia, creatinina); urina I (mioglobínúria: dipstick + para sangue sem hemácias)
- Eletrólitos: Na, K, CÁLCIO, FÓSFORO, ácido úrico
- Gasometria arterial (acidose); hemograma e coagulograma (risco de CIVD)
- ECG: principalmente se distúrbio de potássio ou cálcio

TRATAMENTO — HIDRATAÇÃO É A BASE

Rx PROTEGER O RIM

Trauma: seguir protocolo de trauma e ABCDE
Monitorização cardíaca contínua
HIDRATAÇÃO VIGOROSA: cristalóide 1-2 L na primeira hora; ajustar conforme diurese
Sondagem vesical (SVD) e meta de diurese 200-300 mL/h
Corrigir a causa de base quando possível; Alopurinol para hiperuricemia
Hipercalemia: seguir protocolo (gluconato de cálcio, insulina+glicose, etc.)

CONCEITO — CUIDADO COM O CÁLCIO

NÃO REPOR CÁLCIO DE ROTINA

- A hipocalcemia da rabdomiólise é geralmente ASSINTOMÁTICA e transitória
- NÃO repor cálcio de rotina (o cálcio pode redepósitar no músculo e gerar hipercalemia na recuperação)
- Repor cálcio APENAS se hipocalcemia sintomática ou hipercalemia grave com instabilidade
- Bicarbonato/manitol são controversos — a hidratação vigorosa é a medida com maior respaldo
- Foco: manter perfusão renal e débito urinário altos

INTERNAÇÃO

INDICAÇÕES

- ☐ Todo paciente com diagnóstico de rabdomiólise tem indicação de internação
- ☐ Objetivo: controle de hidratação, débito urinário e complicações
- ☐ Monitorar CPK, função renal e eletrólitos seriados
- ☐ Vigiar hipercalemia (ECG) e síndrome compartimental
- ☐ Avaliação nefrológica se IRA estabelecida / necessidade de diálise

MODELO DE REGULAÇÃO / TRANSFERÊNCIA

RESUMO PARA REGULAÇÃO

- Rabdomiólise (CPK ____); causa: ____ (trauma/esforço/droga/medicamento/imobilização).
- Coloração da urina: ____; débito urinário: ____ mL/h; alterações no ECG: sim/não.
- Eletrólitos: K ____, Ca ____, fósforo ____; função renal: ureia/creatinina ____.
- Conduta: hidratação ____ mL na 1a hora + SVD (meta 200-300 mL/h). Solicito internação para vigilância renal.

FIXAÇÃO — QUESTÕES DE RESIDÊNCIA

QUESTÃO 1

USP-SP / Adaptada

Paciente encontrado caído após imobilização prolongada, urina escura, CPK 28.000. Qual a principal medida terapêutica?

- A) Restrição hídrica
- B) Hidratação venosa vigorosa com meta de diurese 200-300 mL/h e sondagem vesical
- C) Reposição rotineira de cálcio
- D) Furosemida isolada de imediato
- E) Apenas observação

QUESTÃO 2

AMRIGS / Adaptada

Qual é o exame de maior sensibilidade para o diagnóstico de rabdomiólise?

- A) Mioglobina urinária isolada
- B) CPK (creatinofosfoquinase)
- C) Ácido úrico
- D) Lactato
- E) Ureia

QUESTÃO 3

SES-DF / Adaptada

Qual distúrbio eletrolítico é a complicação potencialmente fatal mais temida na rabdomiólise?

- A) Hipernatremia
- B) Hipercalemia
- C) Hipocloremia
- D) Hiper magnesemia
- E) Hiponatremia

QUESTÃO 4

UNIFESP / Adaptada

Sobre a hipocalcemia na rabdomiólise, é correto:

- A) Deve ser sempre corrigida com cálcio endovenoso
- B) Geralmente é assintomática e NÃO se repõe cálcio de rotina (risco de hipercalemia de rebote)
- C) Indica transfusão de cálcio em todos os casos
- D) É sinal de bom prognóstico e dispensa monitorização
- E) Contraindica a hidratação venosa

QUESTÃO 5

UFRJ / Adaptada

Mesmo sem dor muscular, a rabdomiólise deve ser suspeitada porque:

- A) A dor está presente em 100% dos casos
- B) Mais da metade dos pacientes não apresenta dor muscular; urina escura e fraqueza podem ser as únicas pistas
- C) A CPK é sempre normal
- D) Nunca causa lesão renal
- E) Só ocorre após trauma

GABARITO COMENTADO

QUESTÃO 1 → Resposta: B

A base do tratamento da rabdomiólise é a hidratação venosa vigorosa (1-2 L na 1ª hora, ajustando pela diurese) com meta de diurese de 200-300 mL/h e sondagem vesical, para proteger o rim da mioglobínúria.

QUESTÃO 2 → Resposta: B

A CPK é o marcador de maior sensibilidade; valores > 5.000 (ou 5x o limite) confirmam rabdomiólise. A mioglobina sérica/urinária tem meia-vida curta e é menos confiável.

QUESTÃO 3 → Resposta: B

A hipercalemia é a complicação eletrolítica mais temida (potencialmente fatal por arritmia), pela liberação maciça de potássio intracelular — exige monitorização cardíaca e tratamento imediato.

QUESTÃO 4 → Resposta: B

A hipocalcemia da rabdomiólise costuma ser assintomática e transitória; não se repõe cálcio de rotina, pois o cálcio depositado no músculo pode ser liberado na recuperação, causando hipercalemia. Repor só se sintomática ou hiperK grave.

QUESTÃO 5 → Resposta: B

Mais da metade dos pacientes não tem dor muscular; urina escura (castanho-avermelhada) e fraqueza podem ser as únicas manifestações. Por isso, deve-se manter alto índice de suspeição e dosar CPK.

SM24
Suporte ao Plantão Médico